スタートプラン｜¥10,000 vs ¥29,800 の分岐ルール

基本の考え方

院長がどこまで「本気度」を示しているかで価格を分ける。無料ではなく有料にしたことで「お試しだけど投資意識がある層」を獲得する設計。

ルール案①｜提供コンテンツの量で分ける【最もシンプル】

	¥10,000	¥29,800
LINE 診断	✅	✅
健康コラム配信	✅	✅
エクササイズ動画	✅	✅
健康経営簡易チェック	✅	✅
整体体験（初回）	❌	✅
院長との初回ヒアリング 30 分	❌	✅

理由： ¥29,800 は「整体という身体への直接介入」と「院長との接点」が加わる。体感が生まれるため竹への転換率が上がる。¥10,000 はコンテンツ消費型、¥29,800 は体験型として明確に差別化できる。

ルール案②｜スタッフ人数で分ける【院の規模で自動判定】

	¥10,000	¥29,800
スタッフ数	～5 名以下	6 名以上
対象イメージ	小規模・個人院	標準規模・法人系

理由： スタッフが多いほどコンテンツの恩恵を受ける人数が増え、提供価値が高くなる。院長も「スタッフ数が多い＝費用対効果が高い」と納得しやすい。担当者が迷わず即判断できる明確な基準になる。

ルール案③｜契約期間で分ける【コミット度で判定】

	¥10,000	¥29,800
契約期間	月次（いつでも解約可）	3 ヶ月以上コミット
解約条件	翌月から停止可	期間内は継続

理由： 3 ヶ月のコミットを取ることでベーシックへの転換検討期間が確保できる。¥10,000 は「とにかく入ってもらう」導線、¥29,800 は「ある程度本気の院長」を選別するフィルターになる。チームとして追うべきは¥29,800 の院長。

ルール案④｜初回訪問あり・なしで分ける【担当者の稼働で分ける】

	¥10,000	¥29,800
提供形態	オンライン・LINE 完結	訪問あり（月 1 回）

	¥10,000	¥29,800
担当者稼働	最小限	面談・整体導線含む

理由：¥10,000 はスケール設計（何院でも同時対応できる）、¥29,800 は関係構築型。原価の観点からも¥10,000 は固定費のみ、¥29,800 は人件費・移動費が発生するため価格差に合理的な根拠ができる。チーム内での工数管理もしやすくなる。

【推奨】スタートプランの分岐ルール まとめ

複数の軸を組み合わせた**シンプルな判断フロー**がチームには最も使いやすいです。

スタッフ 5 名以下　かつ　訪問不要　→　¥10,000
↓
スタッフ 6 名以上　または　整体体験・初回面談を含む　→　¥29,800

コンプリートプラン｜¥200,000 vs ¥300,000 の分岐ルール

基本の考え方

整体の頻度と担当者の稼働量が主な原価変動要因。前回の原価設計書で「整体月 2 回か週 1 回かで原価が¥30,000〜45,000 変動する」と確認済みのため、ここを分岐軸の中心に据える。

ルール案①｜整体回数で分ける【最も明確・原価と連動】

	¥200,000	¥300,000
出張整体	月 2 回	週 1 回（月 4 回）
出張エクササイズ	月 1 回	月 2 回
セミナー	月 1 回	月 2 回
院長面談	月 1 回 60 分	月 1 回 90 分＋随時相談
離職予兆アラート	✅	✅
健康経営優良法人支援	✅	✅
四半期スコアレポート	✅	✅

理由：原価の最大変動要因が整体回数（月 2 回と週 1 回で¥30,000〜45,000 差）のため、サービス内容と価格差が完全に連動する。院長への説明も「整体が月 2 回か週 1 回かの違いです」と一言で伝わる。担当者が迷わない最もシンプルなルール。

ルール案②｜スタッフ人数で分ける【規模に応じた自動判定】

	¥200,000	¥300,000
スタッフ数	〜9 名以下	10 名以上
整体 1 回あたりの対象人数	〜8 名	10 名以上

理由: 整体は 1 セッション最大 8 名までが適切な提供品質の上限。10 名以上になると 2 セッション必要になり稼働・外注費が増加する。人数という客観的な基準で価格が自動決定されるため、担当者の主観が入らず交渉トラブルが起きにくい。

ルール案③｜健康経営優良法人の取得サポート深度で分ける

	¥200,000	¥300,000
優良法人取得支援	資料提供・アドバイスのみ	申請書類作成・伴走サポート込み
担当者稼働	最小限	申請期間中は月 2〜3h 追加

理由: 健康経営優良法人の認定取得は採用ブランディングに直結する付加価値。「自分でやるか・丸投げできるか」は院長にとって大きな差。¥300,000 は「手間ゼロで認定まで取れる」という明確な差別化ポイントになる。

ルール案④｜契約期間で分ける【コミット度で判定】

	¥200,000	¥300,000
最低契約期間	6 ヶ月	12 ヶ月
年間費用	¥1,200,000	¥3,600,000
解約違約金	あり（残月数×50%）	あり（残月数×50%）

理由: 長期コミットほど院長の本気度が高く継続率も上がる。¥300,000 は年間 360 万円の投資判断であり、それだけの覚悟がある院長に提供する。チームとして「¥300,000 の院長をむやみに増やさない」という品質管理の基準にもなる。

【推奨】コンプリートプランの分岐ルール まとめ

スタッフ 9 名以下　かつ　整体月 2 回で十分　→　¥200,000
↓
スタッフ 10 名以上　または　週 1 整体を希望　または　優良法人取得を丸投げしたい
→　¥300,000

全プラン 価格ルール 一覧表（チーム共通認識版）

プラン	低価格	高価格	主な分岐軸
スタート	¥10,000	¥29,800	スタッフ 5 名以下 or 訪問なし → 低価格
ベーシック	¥80,000	固定	変動なし・固定価格
コンプリート	¥200,000	¥300,000	スタッフ 10 名以上 or 週 1 整体 or 優良法人丸投げ → 高価格

ベーシックを固定にしているのは**「利益の柱を価格交渉の対象にしない」**という理由からです。ベーシックだけ固定にすることでチームの収益予測が立てやすくなります。

前提：なぜ「やらないこと」が成約率を上げるのか

営業の失敗の多くは「やりすぎ」「早すぎ」「説明しすぎ」から生まれます。院長の脳は**防衛反応が強い**（新しいコスト＝リスクと判断する）ため、攻めるほど逃げられる構造になっています。

カテゴリ別「やらないこと」全リスト

🔴 カテゴリ 1｜初回接触・アプローチ

---

① 初回から全プランを説明しない

理由：情報過多は「考えます」を生む。人間の脳は選択肢が 3 つ以上になると決断を先送りする（決定回避の法則）。初回は「松の無料体験」一択しか提示しない。竹・梅は院長が「もっと知りたい」と言ってから出す。

---

② 初回に金額を言わない

理由：価格は「価値を理解した後」に提示しないと拒絶反応しか生まない。STEP1〜3（恐怖→共感→安全）を経ていない状態で「月 7 万円です」と言うと、扁桃体が即座にシャットダウンする。

---

③ アポなし飛び込みをしない

理由：歯科医院の院長は診療中の割り込みを極端に嫌う。信頼ゼロの状態での接触は「迷惑な業者」として記憶され、後からのアプローチが全て閉じられる。紹介・LINE・セミナー経由の温かいリードに絞る。

---

④「健康経営」という言葉を最初に使わない

理由：院長にとって「健康経営」は「コストがかかる行政対応」のイメージが強い。最初の入り口は「採用コストの話」「衛生士が辞める話」など院長が今困っていることから入る。健康経営という言葉は後から定義する。

🟠 カテゴリ 2｜商談・提案の進め方

---

⑤ 資料を最初から全部見せない

理由：15 枚のスライドを最初から順番に見せると院長の集中力が 4 枚目で切れる。商談は「会話」であり「説明会」ではない。資料は補助ツールとして使い、基本は問いかけと傾聴で進める。

---

⑥ 院長の話を遮らない

理由：院長が話し始めたら、それは「本音が出ている瞬間」。ここで担当者が割り込んで解決策を提示すると「話を聞いてくれない業者」になる。傾聴→共感→提案の順を守る。成約率が高い営業担当は話す量が少ない。

---

⑦「他の医院でも効果がありました」を証拠なしに言わない

理由：院長は医師であり論理的思考が強い。根拠のない事例話は信頼を下げる。事例を使うなら「スタッフ離職が 1 名減り、採用コスト 180 万円が浮いた医院があります」など数字と具体性を持って話す。

---

⑧「絶対に効果が出ます」と断言しない

理由：過度な約束は後のクレームと解約の原因になる。「多くの医院で◯◯の変化が起きています」という表現にとどめ、院長自身に「うちでも同じになるかも」と想像させる。押し付けより、気づかせる設計。

---

⑨ 競合他社を悪く言わない

理由：競合批判は聞いている院長に「この人は信用できない」という印象を与える。人は「他者を批判する人」を信頼しない（心理学的に確認済み）。FU の優位性は「うちにしかできないこと」だけで語る。

---

⑩ 一度の商談でクロージングまで持っていこうとしない

理由：歯科院長は多忙で即断が難しく、かつプライドが高い。「今日決めてください」という圧力は必ず反発を生む。「今日は松だけ始めましょう」という小さな Yes を積み重ねるほうが長期的な成約率と継続率が上がる。

🟡 カテゴリ 3｜言葉・説明のしかた

---

⑪ 専門用語・カタカナを多用しない

理由：「プレゼンティズム」「ワークエンゲージメント」「側坐核」などを連発すると院長は「理解できない＝自分ごとにならない」状態になる。エビデンスは武器だが、会話では「出勤しているのに頭が働いていない状態、先生もご存じですか？」のように日常語に翻訳して使う。

---

⑫「福利厚生として」という言い方をしない

理由：「福利厚生」はコスト・義務・従業員への施しというフレームを呼び込む。院長に刺さる言葉は「医療品質への投資」「採用コストの削減」「離職防止の経営判断」。同じ内容でも言葉のフレーム次第で意思決定が変わる。

---

⑬ 数字を一度に複数出しすぎない

理由：「76.4%・3.39 倍・200 万円・年 30 万円・1→3 リターン」を一気に出すと脳が処理しきれず、どの数字も記憶に残らない。1 回の商談で使う数字は最大 2〜3 個。最も刺さる「1 人辞めると 200 万円」だけに絞るほうが記憶に残り行動につながる。

---

⑭「いかがでしょうか？」で終わらない

理由：「いかがでしょうか？」は院長に「考える時間をください」という逃げ道を与える。クロージングは必ず「まずは無料から始めますか？それとも本気で離職を止めにいきますか？」という二択設計で終わる。どちらを選んでも前進する構造を作る。

🟢 カテゴリ 4｜フォロー・関係構築

---

⑮ 断られた翌日すぐに再アプローチしない

理由：断りの直後は院長の中で「断った理由を正当化する思考」が働いている（認知的不協和の解消）。最低 1〜2 週間空けてから、新しい情報・データ・事例をきっかけに再接触する。「前回の続きです」ではなく「新しい話があって」という入り方が有効。

---

⑯ 松プランの院長に早期アップセルをしない

理由：松導入後、信頼が形成されていない段階で「竹はいかがですか？」と提案すると「やっぱり売りたいだけか」と思われ関係が壊れる。転換のタイミングは「院長またはスタッフから反応が来た瞬間」。LINE の開封率・整体体験後の感想・簡易チェックの低スコアを転換トリガーとして設計する。

---

⑰ 成約後に「ありがとうございました」で終わらない

理由：成約直後は院長が「本当にこれでよかったか」と不安になる（バイヤーズリモース）タイミング。「先生の判断は正しいです。◯◯医院でも同じ選択をして◯ヶ月後にこうなりました」と即座に安心材料を提供する。継続率が大きく変わる。

🔵 カテゴリ 5｜チーム運営・社内共通認識

---

⑱ 担当者ごとに違う価格・条件を提示しない

理由：「あの担当者は 5 万でやってくれると言っていた」という話が医院間で広がると価格の信頼性が崩壊する。特に歯科業界はホワイトエッセンス加盟院同士のコミュニティが強く、口コミが速い。例外対応は原則禁止にする。

---

⑲ 上司への報告で「感触が良かったです」だけで終わらない

理由：「感触が良い」は情報ではない。チームで共有すべきは「院長のタイプ（数字型/感情型/多忙型）」「今最も困っていること」「誰が意思決定者か」の 3 点。これが揃っていないと次のアプローチが属人化し、担当が変わると 1 からやり直しになる。

---

⑳ 成約率だけを KPI にしない

理由：成約率だけを追うと「無理なクロージング→解約」が増える悪循環に入る。チームの KPI は「成約率」「松→竹転換率（目標 30〜40%）」「竹継続率（目標 80%以上）」「紹介発生率」の 4 つで管理する。特に継続率は事業の生命線。

まとめ表

#	やらないこと	効果
①②	初回に全プラン・金額を出さない	決定回避を防ぐ
③④	飛び込み・健康経営という言葉を最初に使わない	拒絶反応を防ぐ
⑤⑥	資料を全部見せない・話を遮らない	院長の本音を引き出す
⑦⑧	根拠なし事例・断言しない	信頼の毀損を防ぐ
⑨⑩	競合批判・1 回でのクロージングをしない	長期関係を守る
⑪⑫	専門用語・福利厚生フレームを使わない	自分ごと化を促す
⑬⑭	数字の出しすぎ・曖昧クロージングをしない	記憶と行動に残す
⑮⑯	断られ直後の再アプローチ・早期アップセルをしない	関係を壊さない
⑰	成約後に安心材料を渡さないで終わらない	継続率を守る
⑱⑲⑳	価格バラつき・感触報告・成約率単一 KPI をしない	チーム品質を均一化

スタートプラン｜¥10,000 vs ¥29,800 の分岐ルール

院長がどこまで「本気度」を示しているかで価格を分ける。無料ではなく有料にしたことで「お試しだけど投資意識がある層」を獲得する設計。

ルール案①｜提供コンテンツの量で分ける【最もシンプル】

	¥10,000	¥29,800
LINE 診断	✅	✅
健康コラム配信	✅	✅
エクササイズ動画	✅	✅
健康経営簡易チェック	✅	✅
整体体験（初回）	❌	✅
院長との初回ヒアリング 30 分	❌	✅

理由： ¥29,800 は「整体という身体への直接介入」と「院長との接点」が加わる。体感が生まれるため竹への転換率が上がる。¥10,000 はコンテンツ消費型、¥29,800 は体験型として明確に差別化できる。

ルール案②｜スタッフ人数で分ける【院の規模で自動判定】

	¥10,000	¥29,800
スタッフ数	～5 名以下	6 名以上
対象イメージ	小規模・個人院	標準規模・法人系

理由： スタッフが多いほどコンテンツの恩恵を受ける人数が増え、提供価値が高くなる。院長も「スタッフ数が多い＝費用対効果が高い」と納得しやすい。担当者が迷わず即判断できる明確な基準になる。

ルール案③｜契約期間で分ける【コミット度で判定】

	¥10,000	¥29,800
契約期間	3 ヶ月以内（お試しのため）	3 ヶ月以上コミット
解約条件	翌月から停止可	期間内は継続

理由： 3 ヶ月のコミットを取ることでベーシックへの転換検討期間が確保できる。¥10,000 は「とにかく入ってもらう」導線、¥29,800 は「ある程度本気の院長」を選別するフィルターになる。チームとして追うべきは¥29,800 の院長。

ルール案④｜初回訪問あり・なしで分ける【担当者の稼働で分ける】

	¥10,000	¥29,800
提供形態	オンライン・LINE 完結	訪問あり（月 1 回）
担当者稼働	最小限	面談・整体導線含む

理由：¥10,000 はスケール設計（何院でも同時対応できる）、¥29,800 は関係構築型。原価の観点からも¥10,000 は固定費のみ、¥29,800 は人件費・移動費が発生するため価格差に合理的な根拠ができる。チーム内での工数管理もしやすくなる。

【推奨】スタートプランの分岐ルール まとめ

複数の軸を組み合わせた**シンプルな判断フロー**がチームには最も使いやすいです。

スタッフ 5 名以下　かつ　訪問不要　→　¥10,000
↓
スタッフ 6 名以上　または　整体体験・初回面談を含む　→　¥29,800

コンプリートプラン｜¥200,000 vs ¥300,000 の分岐ルール

基本の考え方

整体の頻度と担当者の稼働量が主な原価変動要因。前回の原価設計書で「整体月 2 回か週 1 回かで原価が¥30,000〜45,000 変動する」と確認済みのため、ここを分岐軸の中心に据える。

ルール案①｜整体回数で分ける【最も明確・原価と連動】

	¥200,000	¥300,000
出張整体	月 2 回	週 1 回（月 4 回）
出張エクササイズ	月 1 回	月 2 回
セミナー	月 1 回	月 2 回
院長面談	月 1 回 60 分	月 1 回 90 分＋随時相談
離職予兆アラート	✅	✅
健康経営優良法人支援	✅	✅
四半期スコアレポート	✅	✅

理由：原価の最大変動要因が整体回数（月 2 回と週 1 回で¥30,000〜45,000 差）のため、サービス内容と価格差が完全に連動する。院長への説明も「整体が月 2 回か週 1 回かの違いです」と一言で伝わる。担当者が迷わない最もシンプルなルール。

ルール案②｜スタッフ人数で分ける【規模に応じた自動判定】

	¥200,000	¥300,000
スタッフ数	〜9 名以下	10 名以上
整体 1 回あたりの対象人数	〜8 名	10 名以上

理由：整体は 1 セッション最大 8 名までが適切な提供品質の上限。10 名以上になると 2 セッション必要になり稼働・外注費が増加する。人数という客観的な基準で価格が自動決定されるため、担当者の主観が入らず交渉トラブルが起きにくい。

ルール案③｜健康経営優良法人の取得サポート深度で分ける

	¥200,000	¥300,000
優良法人取得支援	資料提供・アドバイスのみ	申請書類作成・伴走サポート込み
担当者稼働	最小限	申請期間中は月 2〜3h 追加

理由：健康経営優良法人の認定取得は採用ブランディングに直結する付加価値。「自分でやるか・丸投げできるか」は院長にとって大きな差。¥300,000 は「手間ゼロで認定まで取れる」という明確な差別化ポイントになる。

ルール案④｜契約期間で分ける【コミット度で判定】

	¥200,000	¥300,000
最低契約期間	6 ヶ月	12 ヶ月
年間費用	¥1,200,000	¥3,600,000
解約違約金	あり（残月数×50%）	あり（残月数×50%）

理由：長期コミットほど院長の本気度が高く継続率も上がる。¥300,000 は年間 360 万円の投資判断であり、それだけの覚悟がある院長に提供する。チームとして「¥300,000 の院長をむやみに増やさない」という品質管理の基準にもなる。

【推奨】コンプリートプランの分岐ルール まとめ

スタッフ 9 名以下　かつ　整体月 2 回で十分　→　¥200,000
↓
スタッフ 10 名以上　または　週 1 整体を希望　または　優良法人取得を丸投げしたい
→　¥300,000

全プラン 価格ルール 一覧表（チーム共通認識版）

プラン	低価格	高価格	主な分岐軸
スタート	¥10,000	¥29,800	スタッフ 5 名以下 or 訪問なし → 低価格
ベーシック	¥80,000	固定	変動なし・固定価格
コンプリート	¥200,000	¥300,000	スタッフ 10 名以上 or 週 1 整体 or 優良法人丸投げ → 高価格

FITNESS UNIVERSITY｜営業戦略 × トークスクリプト 完全版

全体の戦略構造

STEP 1　初回接触　　→　「迷惑な業者」にならない最初の 30 秒

STEP 2　アポ取得　　→ 断られにくい依頼の設計
STEP 3　商談ヒアリング　→ 院長に「気づかせる」問いかけ
STEP 4　提案　　→ スタートプランの一択提示
STEP 5　クロージング　　→ 二択で逃げ道をふさぐ
STEP 6　フォロー　　→ 断られても終わらない再設計
STEP 7　アップセル　　→ タイミングを間違えない転換

STEP 1｜初回接触戦略

戦略の核心

最初の接触で「売りに来た人」と思われた瞬間、以降のすべてが閉じる。目標は「成約」ではなく「次の 15 分を取ること」だけ。

やらないこと（復習）

- サービス名を最初に言わない
- 「健康経営」という言葉を使わない
- 料金を一切触れない

🎯 初回接触トークスクリプト（対面・受付経由）

【受付への一言】

「院長先生に少しだけ
採用コストのご相談をしたいのですが、お手すきのタイミングで
2〜3 分だけお時間いただけますか？資料のお渡しだけでも構いません。」

ポイント：「採用コスト」という言葉を使う。院長が今リアルに困っているテーマなので受付が院長に伝えやすくなる。「2〜3 分」と伝えることで心理的ハードルを下げる。

🎯 院長に直接会えた場合（最初の 30 秒）

「先生、突然すみません。FITNESS University の〇〇と申します。

実は歯科医院さんの"採用コストを下げる仕組み"をご提案しているのですが、

衛生士さんが辞めるたびに実質 200 万円以上かかっているってご存じでしたか？」

（→ 院長の反応を待つ。絶対に続けない）

ポイント：最初の問いかけで止まる。院長が「え、そんなにかかるの？」と反応したら次に進む。無反応なら「お時間のある時に 5 分だけ聞いてください」と日程だけ取る。

STEP 2｜アポ取得戦略

戦略の核心

アポは「お願い」ではなく「院長にとって得な時間」として設計する。「無料で診断します」より「先生の医院の数字を見せます」のほうが刺さる。

🎯 アポ取得トークスクリプト

「先生の医院で、今スタッフが何人いて、仮に1人辞めた場合に実際いくらかかるか、

15分で計算してお見せすることができます。

無料ですし、買う買わないは一切関係なく、数字だけお持ちします。

来週と再来週、どちらが診療後にお時間取れますか？」

ポイント:「どちらが」という二択でアポを取る。「いつがいいですか？」はゼロ回答を生む。「数字をお持ちします」は院長の論理脳に刺さる。

🎯 電話・LINEでのアポ取得スクリプト

【件名 / 最初の一文】

「〇〇歯科 院長先生へ衛生士の採用コストを半減させた
15分の試算をご覧いただけませんか？」

【本文】

先生、はじめまして。FITNESS Universityの〇〇です。

突然のご連絡失礼いたします。

歯科医院専門で「スタッフが辞めない仕組み」をご提供しております。

先生の医院規模で計算すると、衛生士1人の離職コストが
実質〇〇万円になる可能性があります。

この数字だけ15分でお見せしたいのですが、今週金曜か来週月曜の診療後、いかがでしょうか？

買う買わないは一切不要です。数字を見て「うちには関係ない」と思っていただいても全く構いません。

ポイント:「買う買わないは不要」という一言が防衛反応を下げる最強フレーズ。スタッフ人数から「〇〇万円」を事前計算して入れると開封率・返信率が上がる。

STEP 3｜商談ヒアリング戦略

戦略の核心

商談の最初の 15 分は「聞く」だけ。担当者が話す量は全体の 30%以下を目標にする。院長が「自分で気づく」状態を作ることが最大の目的。

ヒアリングの順序（絶対に変えない）

① 現状を聞く（事実）
② 困っていることを聞く（感情）
③ 損失を一緒に計算する（数字）
④ 理想を聞く（未来）
⑤ 提案する（解決策）

🎯 ヒアリングトークスクリプト（商談冒頭）

「先生、今日は売り込みではなく、まず先生の医院の状況を
聞かせていただきたいと思っています。

今、スタッフは何名いらっしゃいますか？衛生士さんは何名ですか？」
（→ メモを取りながら聞く）

「ここ 1〜2 年で辞めた方はいましたか？」
（→ 院長が話し始めたら絶対に遮らない）

「そうだったんですね。その時、採用はどうされましたか？紹介会社ですか？」

（→ 共感しながら深堀り）

「紹介会社だとだいたい年収の何%かかりましたか？
……だいたい 80〜100 万くらいかかりましたよね。

実は採用費だけじゃなくて、教育期間の 6 ヶ月、
その方が一人前になるまでの機会損失も含めると、

実質 200 万円を超えることが多いんです。先生の感覚、どうですか？」

ポイント：最後の「先生の感覚、どうですか？」が重要。院長に「自分ごとの数字」として認識させる。担当者が答えを言うのではなく、院長自身に言わせる。

🎯 離職原因の「常識破壊」トーク

「ちなみに先生、衛生士さんが辞める理由って何だと思いますか？」

（→ 院長の答えを聞く。多くは「給与」「人間関係」と答える）

「そうですよね。多くの先生がそうおっしゃいます。

ただ、日本歯科衛生士会の調査で常勤の退職理由の1位が何だと思いますか？

…実は『院長との人間関係』が29%で1位なんです。

給与は22%で、しかも単独での離職原因は少数なんです。

つまり、給与を上げても解決しないケースがほとんどなんです。」

（→ 沈黙。院長の反応を待つ）

ポイント:ここで院長が「え、そうなの？」となれば商談は大きく前進する。沈黙を恐れず待つことが重要。

STEP 4｜提案戦略

戦略の核心

提案はスタートプランの一択のみ。「まず無料で体感してもらう」ことだけがゴール。ベーシック・コンプリートは院長から「もっと詳しく」と言われるまで出さない。

🎯 提案トークスクリプト

「先生、解決策として3つのプランがあるんですが、今日は一番シンプルな話だけします。

まず、月1万円からスタッフの状態を『見える化』する仕組みがあります。

LINEで診断を送るだけで、スタッフが今どんな状態か、
睡眠・疲労・自己肯定感が数値で分かります。

先生が何かするわけじゃないです。仕組みが自動で動くだけです。

これ、先生の医院でも今すぐ動かせるんですが、どうしますか？」

ポイント:「今日は一番シンプルな話だけします」という一言で院長の警戒が下がる。「先生が何かするわけじゃない」は多忙型院長に最も刺さるフレーズ。

STEP 5｜クロージング戦略

戦略の核心

クロージングは「決断させる」ではなく「どちらを選ぶか」の二択設計。「検討します」という逃げ道を構造的に消す。

🎯 クロージングトークスクリプト（基本）

「先生、シンプルに聞かせてください。

今のまま来年も同じ採用コストをかけ続けますか？

それとも、
月１万円でその仕組みを動かしてみますか？」
（→ 沈黙。絶対に先に話さない）

🎯 「考えます」と言われた場合

「もちろんです。
ただ一つだけ確認させてください。

今日ご決断できない理由は
①金額の問題ですか？
②効果が見えないということですか？
③それとも今が忙しいということですか？」

（→ 院長の答えによって次を変える）

【①金額の場合】
「スタートプランは月１万円からです。
衛生士１人の離職コストが 200 万円とすると、20 年分の費用でも届かない計算です。
金額は問題ではないと思いますが、他に何か気になる点がありましたか？」

【②効果が見えない場合】
「それは当然の疑問です。だからこそまず１ヶ月、数字を見てから判断してください。
１ヶ月で意味がないと感じたらすぐ止めていただいて構いません。」

【③忙しい場合】
「先生が何かする必要は一切ありません。LINE を院内に流すだけです。
それも私がやります。先生の時間は 0 です。」

🎯 成約直後のバイヤーズリモース対策トーク

「ありがとうございます。先生の判断は正しいです。

実は先月、〇〇市の〇〇歯科さんも同じタイミングで始めて、

２ヶ月後に『スタッフの顔色が変わった』とおっしゃっていました。

先生の医院も同じように変わっていくと思います。

では来週〇日に、初回の設定をしに伺いますね。」

ポイント:「先生の判断は正しい」という言葉を必ず入れる。成約直後の不安を即座に消す。次のアクションの日程をその場で入れることで契約のリアリティを高める。

STEP 6｜フォロー・断られた後の再アプローチ戦略

戦略の核心

断りは「終わり」ではなく「タイミングが合わなかった」だけ。1〜2 週間後に「新しい情報」を持って戻る。

🎯 断られた後の再アプローチスクリプト（1〜2 週間後）

【LINE・メール】

「先生、先日はお時間いただきありがとうございました。

その後、一つ気になるデータを見つけたので
共有させてください。

歯科衛生士の離職前兆行動は
実は退職の 3〜6 ヶ月前から
すでに出ているという研究があります。

つまり『突然辞めた』ではなく、気づけるサインがあったということです。

先生の医院ではそのサインを今見えていますか？

もし気になれば　また 15 分だけ時間をください。」

ポイント:前回の断りに一切触れない。「新しい情報」として接触することで「しつこい業者」にならない。問いかけで終わることで院長に「気になる」状態を作る。

STEP 7｜アップセル戦略（スタート→ベーシック→コンプリート）

戦略の核心

アップセルは「売る」のではなく「院長が自然に上がりたくなる」タイミングを待つ。転換のサインを見逃さないことが最重要。

転換サイン一覧（チーム共有）

サイン	意味	次のアクション
LINE の開封率が 70%超	院内に浸透している	ベーシックの提案タイミング
整体体験後に院長から連絡	体感が生まれた	即座にベーシック提案
簡易チェックのスコアが低い	課題の認識が生まれた	「数字で詳しく見ましょう」

サイン	意味	次のアクション
「もっと何かできる？」と聞かれた	信頼が形成された	ベーシックの一択提案
他のスタッフが「続けてほしい」と言った	院長以外も動いている	コンプリートの検討タイミング

🎯 スタート→ベーシック転換トークスクリプト

「先生、先月からスタートして
LINE の開封率が〇%だったんですが、

これ、スタッフが
かなり関心を持っている数字なんです。

実はこの状態になった医院に
次のステップをご提案することがあるんですが、

月 8 万円で、
院長先生と月 1 回 15 分話すだけで、
スタッフの課題を数値化して
優先順位を決めていく仕組みがあります。

先生が何か特別なことをするわけじゃなくて、
私と一緒に数字を見るだけです。

やってみますか？」

🎯 ベーシック→コンプリート転換トークスクリプト

「先生、3 ヶ月間の
スコアレポートをまとめました。

〇〇さんの数値が
ここ 2 ヶ月で下がっています。

このパターン、
過去のデータだと
3〜4 ヶ月後に離職につながる
ケースが多いんです。

今のベーシックでは
月 1 回の整体で対応していますが、

週 1 回に変えると
このスコアが改善する可能性が高いです。

コンプリートプランに変えると、
整体が週 1 になり、
このリスクを先手で潰せます。

今の先生の医院の状況だと、
コンプリートに上げたほうが
年間で見たときのコストが
下がる可能性が高いですが
どうしますか？」

ポイント:「あなたのために言っている」が伝わる設計。データを根拠に提案することで「売り込み」ではなく「伴走者からのアドバイス」になる。

チーム共通の数字（暗記必須 3 つ）

商談でとっさに使える数字はこの 3 つだけ。それ以外は出さない。

数字	使う場面
1 人辞めると 200 万円	最初の損失提示・クロージング
退職理由 1 位は院長との関係（29%）	常識破壊・給与では解決しない根拠
離職の前兆は 3〜6 ヶ月前から出る	フォロー・アップセルの根拠

院長タイプ別 最初の一言まとめ

タイプ	最初の一言
数字思考型	「1 人辞めると 200 万円かかります。計算してみましょうか？」
感情共感型	「先生、辞めてほしくなかったスタッフって、いましたか？」
超多忙型	「先生は何もしなくていいです。仕組みが動くだけです。」
未来志向型	「3 年後、採用に困らない医院を作れる仕組みがあります。」

了解です。「アポが取れない」が最重要課題ですね。電話と対面訪問に絞って、アポ取得に特化した戦略とスクリプトを完全設計します。

アポ取得 完全攻略マニュアル

「なぜアポが取れないか」の本質から設計する

まず原因の診断

アポが取れない理由は大きく3つに分類されます。チームでどれに当てはまるか確認してください。

原因	症状	対策の方向性
A：そもそも話を聞いてもらえない	受付でブロックされる・電話を切られる	最初の一言の設計
B：話は聞くが「結構です」で終わる	院長に繋がるが断られる	価値提示の設計
C：「また今度」で先送りされる	日程が決まらない	クロージング設計

根本戦略：アポは「お願い」しない

チームに最初に共有すべき最重要認識です。

❌ **今やっていること（推測）**「一度お話を聞いていただけませんか？」「サービスのご紹介をさせてください」

✅ **正しい設計**「院長先生にとって得な情報をお持ちします」「先生の医院の数字を計算してお見せします」

アポは「取りに行く」のではなく「院長が会いたくなる理由を作る」設計に切り替える。これだけでアポ率が大きく変わります。

電話編｜アポ取得完全スクリプト

電話の構造（全体像）

① 受付突破（15秒）
　↓
② 院長接続（10秒）
　↓
③ 興味喚起（30秒）
　↓
④ 日程取得（15秒）
　↓
合計：約70秒で完結させる

70 秒を超えると院長の集中力が切れる。短く・鋭く・一点突破が原則。

---

① 受付突破スクリプト

受付は「業者をブロックする」のが仕事です。業者っぽい言葉を一切使わないことが鍵。

【パターン A：採用コストの話として入る】

「〇〇歯科さんですか？
お忙しいところ失礼します。

FITNESS University の〇〇と申します。

衛生士さんの採用コストに関して
院長先生に直接お伝えしたいことがあり
お電話しました。

院長先生はいらっしゃいますか？」

ポイント：「採用コスト」という言葉は受付が院長に伝えやすいワード。「サービスのご案内」は絶対に使わない。

【パターン B：紹介・知人経由として入る場合】

「〇〇歯科さんの院長先生に
〇〇先生からご紹介いただいた件で
ご連絡しております。

院長先生はいらっしゃいますか？」

ポイント：紹介がある場合は必ず最初に出す。受付のブロック率が大幅に下がる。紹介がなくても「ホワイトエッセンス加盟院の〇〇先生から情報を共有いただきまして」という形で繋げることも可能。

【受付に「どのような件ですか？」と聞かれた場合】

「はい、衛生士さんの離職コストについて
院長先生に直接ご確認したいことがあります。
2～3 分だけお繋ぎいただけますか？」

「サービスのご案内です」は絶対に言わない。「確認したいことがある」というスタンスにする。

【「今は忙しい」と言われた場合】

「承知しました。
先生がお手すきになるのは
午前診療の後でしょうか、
それとも夕方以降でしょうか？

その時間帯にまたお電話します。」

「いつがよろしいですか？」ではなく二択で聞く。「またかけ直します」だけで終わると永遠に繋がらない。

---

② 院長接続後のスクリプト

院長に繋がった最初の 10 秒が全て。この 10 秒で「この話は聞く価値がある」と思わせる。

【基本スクリプト：損失提示型】

「先生、突然のお電話失礼します。
FITNESS University の〇〇です。

単刀直入にお聞きしますが、

衛生士さんが 1 人辞めると
実質 200 万円以上かかるって
ご存じでしたか？」

（→ 必ず止まって院長の反応を待つ）

ポイント：「単刀直入に」という言葉で院長の警戒が下がる。院長は回りくどい話が嫌い。問いかけで終わることで院長が自然に話し始める。

【院長が「知ってる」「そうですね」と答えた場合】

「そうですよね。

ただ多くの先生が
その原因を『給与』だと思っているんですが、

実は歯科衛生士会の調査で
退職理由の1位が
院長との関係性だったんです。

給与を上げても解決しない
可能性があるということです。

この話、5分だけ
直接お聞きいただけませんか？」

【院長が「知らなかった・そんなにかかるの？」と答えた場合】

「そうなんです。
採用費・教育費・習熟期間の損失を
合わせると200万円を超えるんです。

先生の医院のスタッフ数で
実際にいくらかかるか
15分で計算してお見せできます。

今週か来週、
診療後に15分だけ
お時間いただけますか？」

---

③ 日程取得スクリプト（クロージング）

ここが最も失敗しやすい場所です。「検討します」で終わらせない設計が必要。

【日程取得の基本】

「今週の木曜か金曜、
診療後の17時以降はいかがですか？

15分だけで大丈夫です。
資料もA4一枚だけ持ちます。」

「いつがよろしいですか？」は絶対に使わない。必ず二択か三択で提示する。「15分」「A4一枚」で心理的ハードルを最小化する。

【「忙しい」と言われた場合】

「承知しました。

では診療が落ち着く
来月でも構いません。

ただ一つだけ確認させてください。

今、衛生士さんの離職リスクが
高い状態かどうかだけ
10 分で確認できるので、

それだけでもやってみませんか？

来月の第一週と第二週、
どちらが比較的お時間取れますか？」

【「今は必要ない」と言われた場合】

「そうですか、承知しました。

一つだけ聞かせてください。

今スタッフの状態が
見えている状態ですか？

見えているなら
確かに不要だと思います。

見えていないなら、
それだけは確認しておいたほうが
先生のためになると思っています。

15 分だけ、数字を見るだけで
構わないんですが、いかがですか？」

ポイント:「必要ない」に反論しない。「見えているか・見えていないか」という問いに変換することで院長が自分で考え始める。

対面訪問編｜アポ取得完全スクリプト

対面訪問の構造（全体像）

① 受付での第一印象（30 秒）

↓
② 院長への一言（60 秒）
↓
③ 名刺・資料の渡し方（30 秒）
↓
④ 次のアポの取り方（30 秒）
↓
合計：約 2 分半で退出する

対面初回訪問の目的は「成約」でも「提案」でもない。「次の 15 分のアポを取ること」だけ。長居は百害あって一利なし。

---

① 受付での第一印象スクリプト

「こんにちは、
FITNESS University の〇〇と申します。

院長先生に少しだけ
衛生士さんの採用コストに関して
お伝えしたいことがあり、
伺いました。

今日は資料のお渡しだけで
構いません。
先生はいらっしゃいますか？」

ポイント:「資料のお渡しだけ」という言葉で受付の心理的ハードルを下げる。清潔感・笑顔・低姿勢が受付突破の 9 割を決める。

---

② 院長に会えた場合のスクリプト

【診療中・忙しそうな場合】

「先生、お忙しいところ失礼します。
FITNESS University の〇〇です。

一つだけ確認させてください。

衛生士さんが 1 人辞めると
実質 200 万円かかるって
ご存じでしたか？

（→ 反応を待つ）

この話を 15 分だけ聞いてください。
今日じゃなくて構いません。

今週と来週、
診療後に 15 分だけ
いただけますか？」

【少し話せそうな場合】

「先生、少しだけよろしいですか。

実は歯科衛生士さんの
離職原因について
面白いデータがあって、

多くの先生が給与が原因だと
思っているんですが、
実は違うんです。

1 位は院長との関係性なんです。

ということは、
給与を上げても
解決しない可能性があります。

その解決策を 15 分で
お話できるんですが、
今週か来週、
お時間いただけますか？」

---

③ 名刺・置き資料の渡し方

「こちら名刺です。

それとこの資料なんですが、
1 枚だけなので
後で見ていただければ。

衛生士 1 人の離職コストが
いくらかを計算した表です。

先生の医院のスタッフ数で
当てはめると〇〇万円になります。」

ポイント：置き資料は A4 一枚のみ。「先生の医院の数字」に事前に当てはめておく。自分の医院の数字が入っている資料は捨てられない。

---

④ 院長に会えなかった場合のスクリプト

「承知しました。

では先生にこちらをお渡しください。

（A4 一枚の資料を渡す）

スタッフさんが辞めた場合の
実際のコストを計算した資料です。

先生が見て気になれば
〇〇までご連絡ください、
とお伝えいただけますか？

来週またお伺いしてもよろしいですか？
〇曜日の午後にまた来ます。」

ポイント：「来週また来る」という日程を受付に伝えておく。次回は「先週伺った〇〇です」と言えるので受付突破率が上がる。

「アポが取れない」を根本解決する 5 つの設計変更

---

① 訪問・電話の時間帯を変える

時間帯	推奨度	理由
午前診療中（9〜12 時）	❌	診療に集中しており割り込み厳禁
昼休み（12〜14 時）	⚠️	院長が昼食・休憩中。可能だが短時間で
午後診療前（13〜14 時）	✅	比較的余裕がある最良の時間帯
診療終了後（17〜19 時）	✅	院長が落ち着いており最も話しやすい
土曜午後	✅	午前のみ診療の医院が多く午後は空いていることが多い

---

② 電話の前に LINE・手紙で「予告」を入れる

【電話の前日に送る LINE メッセージ】

「〇〇歯科 院長先生へ

FITNESS University の〇〇です。

明日〇時頃、
衛生士さんの採用コストについて
2 分だけお電話させてください。

先生の医院の試算を
持ってお電話します。」

予告があるだけでアポ率が 30〜40%上がる。突然の電話は防衛反応を生むが、予告された電話は「準備」が生まれる。

---

③ 最初の訪問は「渡すだけ」に設計する

最初の訪問で「話を聞いてください」は欲張りすぎ。

1 回目訪問：資料を渡すだけ・名前を覚えてもらうだけ
2 回目訪問：「先日の資料を見ていただけましたか？」
3 回目訪問：本格的なアポの依頼

3 回接触の法則。1 回目で断られても「失敗」ではなく「想定通り」と捉える。

---

④「断り文句」を事前に想定しておく

断り文句	返し方
「今は忙しい」	「来月でも構いません。〇日と〇日どちらが比較的空いていますか？」
「必要ない」	「今スタッフの状態が見えていますか？見えていれば確かに不要です」
「お金がない」	「月 1 万円です。衛生士 1 人の離職コストの 200 分の 1 です」
「他でやっている」	「そうですか。どんなことをされていますか？（聞く）」
「考えます」	「何が引っかかっていますか？①金額②効果③タイミングどれですか？」

---

⑤ アポ取得の KPI を変える

今チームが持っている KPI が「成約数」だけなら、行動量が見えず詰まる原因になります。

指標	目標値（週次）
電話コール数	30 件
受付突破率	50%（15 件）
院長接続率	40%（6 件）
アポ取得率	50%（3 件）

指標	目標値（週次）
商談→成約率	30〜40%（週 1 件）

どこで詰まっているかが数字で見えるようになります。「受付突破率」が低いなら最初の一言を変える。「院長接続後の取得率」が低いなら価値提示を変える、という改善の方向性が明確になります。

チームに今日から配布できる「一枚まとめ」

【アポ取得 最重要ルール 7 か条】

1. 「サービスのご案内」は言わない
   → 「採用コストの確認」として入る

2. 最初の問いかけは「200 万円ご存じですか？」一択

3. 問いかけたら必ず止まる。沈黙を恐れない

4. 日程は必ず二択で提示する

5. 断られても「終わり」にしない
   → 「何が引っかかっていますか？」で理由を聞く

6. 1 回目訪問は渡すだけ。3 回接触を前提にする

7. 電話は午後診療前か診療終了後に絞る